

Cycle de préparation de résidanat Objectif 20

**Dr NADIA CHARFI SELLAMI
SERVICE ENDOCRINOLOGIE SFAX**

FMS /24 juillet 2025

Le diagnostic de diabète est retenu devant :

A- Glycémie veineuse $\geq 1,26\text{g/l}$ à 2 reprises

B- HbA1C à 6,2 % et glycémie à jeun à 1,30 g/l

C- HbA1C à 6,9% et 7,2%

D- Glycémie veineuse aléatoire à 2,2 g/l et signes cardinaux

E- G2h après HGPO75 à 1,8 g/l

Le diagnostic de diabète est retenu devant :

A- Glycémie veineuse $\geq 1,26$ g/l à 2 reprises

B- HbA1C à 6,2 % et glycémie à jeun à 1,30 g/l

C- HbA1C à 6,9% et 7,2%

D- Glycémie veineuse aléatoire à 2,2 g/l et signes cardinaux

E- G2h après HGPO75 à 1,8 g/l

Concernant le prédiabète :

A- Est une situation métabolique rare

B- La glycémie 2 h après charge glucosée est inférieure à 1,4 g/l

C-Il peut évoluer vers le diabète

D-Implique la mise sous mesures hygiéno-diététiques

E- La glycémie à jeun est entre 1 et 1,25 g/l

Concernant le prédiabète :

A- Est une situation métabolique rare

B- La glycémie 2 h après charge glucosée est inférieure à 1,4 g/l

C-Il peut évoluer vers le diabète

D-Implique la mise sous mesures hygiéno-diététiques

E- La glycémie à jeun est entre 1 et 1,25 g/l

Table 2.5

Criteria defining prediabetes*

FPG 100 mg/dL (5.6 mmol/L) to 125 mg/dL (6.9 mmol/L) (IFG)
OR
2-h PG during 75-g OGTT 140 mg/dL (7.8 mmol/L) to 199 mg/dL (11.0 mmol/L) (IGT)
OR
A1C 5.7–6.4% (39–47 mmol/mol)

FPG, fasting plasma glucose; IFG, impaired fasting glucose; IGT, impaired glucose tolerance; OGTT, oral glucose tolerance test; 2-h PG, 2-h plasma glucose.

Parmi les facteurs déclenchants un diabète de type 1 on trouve :

A-Le stress

B-La supplémentation en vitamine D

C-La sédentarité

D-L 'introduction précoce de lait de vache dans l'alimentation

E-L 'infection par les entérovirus

Parmi les facteurs déclenchants un diabète de type 1 on trouve :

A-Le stress

B-La supplémentation en vitamine D

C-La sédentarité

D-L 'introduction précoce de lait de vache dans l'alimentation

E-L 'infection par les entérovirus

Un patient de 64 ans, obese , aux antécédents de diabète chez la mère , consulte pour un syndrome polyurpolydisique avec amaigrissement depuis 5 mois .Le bilan de retentissement est normal .

Le diabète type2 est évoqué devant:

A-Age

B-Antécédents de diabète chez la mère

C-Bilan de retentissement normal

D-Obésité

E- Syndrome polyurpolydisique avec amaigrissement

Un patient de 64 ans, obese , aux antécédents de diabète chez la mère , consulte pour un syndrome polyurpolydisique avec amaigrissement depuis 5 mois .Le bilan de retentissement est normal .

Le diabète type2 est évoqué devant:

A-Age

B-Antécédents de diabète chez la mère

C-Bilan de retentissement normal

D-Obésité

E- Syndrome polyurpolydisique avec amaigrissement

Les arguments en faveur du diabète de type 1 :

A-Début insidieux

B-Cétose spontanée inaugurale

C-Positivité des anticorps anti pancréas

D- Antécédents de vitiligo

E- Présence de rétinopathie au diagnostic

Les arguments en faveur du diabète de type 1 :

A-Début insidieux

B-Cétose spontanée inaugurale

C-Positivité des anticorps anti pancréas

D- Antécédents de vitiligo

E- Présence de rétinopathie au diagnostic

Parmi les médicaments diabétoènes on trouve :

- A- Les antipsychotiques de 2ème génération
- B- Les diurétiques de l'anse
- C- Les anti hypertenseurs centraux
- D- Les oestroprogestatifs
- E- Les bêtabloquants cardiosélectifs

Parmi les médicaments diabétoènes on trouve :

A- Les antipsychotiques de 2ème génération

B- Les diurétiques de l'anse

C- Les anti hypertenseurs centraux

D- Les oestroprogestatifs

E- Les bêtabloquants cardiosélectifs

Parmi les Facteurs environnementaux prédisposants au diabète de type 2 :

A- Répartition androïde de la graisse

B- Consommation excessive de graisses mono insaturées

C- Troubles du sommeil

D- Alimentation hypersalée

E- Age avancé

Parmi les Facteurs environnementaux prédisposants au diabète de type 2 :

A- Répartition androïde de la graisse

B- Consommation excessive de graisses mono insaturées

C- Troubles du sommeil

D- Alimentation hypersalée

E-Age avancé

Le dépistage de diabète de type2 est indiqué en cas de :

A- Obésité morbide

B- Syndrome coronarien

C- Ethylisme chronique

D- Age supérieure à 35 ans

E- Syndrome d'apnée de sommeil

Le dépistage de diabète de type2 est indiqué en cas de :

A- Obésité morbide

B- Syndrome coronarien

C- Ethylisme chronique

D- Age supérieure à 35 ans

E- Syndrome d'apnée de sommeil

Le dépistage de diabète de type2 chez l'adolescent en surpoids est indiqué en cas :

A- Acanthosis nigricans

B- Antécédents familiaux de mort subite

C- HTA

D- Triglycérides supérieurs à 1,5g/l

E- Diabète gestationnel chez la mère lors de sa grossesse

Le dépistage de diabète de type2 chez l'adolescent en surpoids est indiqué en cas :

A- Acanthosis nigricans

B- Antécédents familiaux de mort subite

C- HTA

D- Triglycérides supérieurs à 1,5g/l

E- Diabète gestationnel chez la mère lors de sa grossesse

Le dépistage du diabète peut se faire par :

A- Glycémie veineuse à jeun

B- HbA1C

C- Bandelette urinaire

D- HGPO

E- Fructosamine

Le dépistage du diabète peut se faire par :

A- Glycémie veineuse à jeun

B- HbA1C

C- Bandelette urinaire

D- HGPO

E- Fructosamine

Un patient obèse, consulte à une caravane de santé à cause d'une polyurie polydipsie, une glycémie capillaire pratiquée revient à 2,7g/l

Pour confirmer le diagnostic de diabète chez ce patient on peut compléter par :

A- Recherche de cétonurie

B- HGPO

C- Dosage de l'HbA1c

D- Glycémie veineuse à jeun

E- Glycémie veineuse aléatoire

Un patient obèse, consulte à une caravane de santé à cause d'une polyurie polydipsie, une glycémie capillaire pratiquée revient à 2,7g/l

Pour confirmer le diagnostic de diabète chez ce patient on peut compléter par :

A- Recherche de cétonurie

B- HGPO

C- Dosage de l'HbA1c

D- Glycémie veineuse à jeun

E- Glycémie veineuse aléatoire

Le diabète type2 est retenu , on va compléter chez ce patient pour rechercher un retentissement par:

A-Echographie cardiaque

B-Fond d'oeil

C- Test au monofilament

D- Bilan hépatique

E- Microalbuminurie

Le diabète type2 est retenu , on va compléter chez ce patient pour rechercher un retentissement par:

A-Echographie cardiaque

B-Fond d'oeil

C- Test au monofilament

D- Bilan hépatique

E- Microalbuminurie

Un diabète secondaire à une pancréatite chronique doit être recherché chez un patient ayant un diabète de découverte récente devant :

A-La présence de diarrhée chronique

B- L'éthylisme chronique

C- L'âge avancé

D- Le début brutal

E-L 'Absence d'antécédents familiaux de diabète

Un diabète secondaire à une pancréatite chronique doit être recherché chez un patient ayant un diabète de découverte récente devant :

A-La présence de diarrhée chronique

B- L'éthylisme chronique

C- L'âge avancé

D- Le début brutal

E-L 'Absence d'antécédents familiaux de diabète

Concernant le diabète gestationnel :

- A- Il expose l'enfant au risque de diabète type2
- B- Il augmente le risque de malformation fœtale
- C- Doit être dépisté chez les femmes de plus de 25 ans
- D- Nécessite le dépistage de diabète type2 à 3 mois post partum
- E- Il existe un hyperinsulinisme fœtal

Concernant le diabète gestationnel :

- A- Il expose l'enfant au risque de diabète type2
- B- Il augmente le risque de malformation fœtale
- C- Doit être dépisté chez les femmes de plus de 25 ans
- D- Nécessite le dépistage de diabète type2 à 3 mois post partum
- E- Il existe un hyperinsulinisme fœtal

S, G âgée de 28 ans , obèse aux antécédents d'hyperglycémie modérée à jeun et de macrosomie foétale , enceinte a 25 SA , vous consulte pour le dépistage d'un diabète gestationnel . Elle est sans ATCDS familiaux particuliers et son examen clinique est normal .

Le risque de DG chez cette patiente est augmentée du fait de :

A- Age

B- Prédiabète

C- Antécédents de Macrosomie

D- Antécédents familiaux de diabète

E- Obésité

S, G âgée de 28 ans , obèse aux antécédents d'hyperglycémie modérée à jeun et de macrosomie foétale , enceinte a 25 SA , vous consulte pour le dépistage d'un diabète gestationnel . Elle est sans ATCDS familiaux particuliers et son examen clinique est normal .

Le risque de DG chez cette patiente est augmentée du fait de :

A- Age

B- Prédiabète

C- Antécédents de Macrosomie

D- Antécédents familiaux de diabète

E- Obésité

Le dépistage du diabète gestationnel chez cette patiente repose sur la réalisation de :

A- HGPO75

B- HbA1c

C- Fructosamine

D- Dosage du C peptide

E- Glycémie post repas test

Le dépistage du diabète gestationnel chez cette patiente repose sur la réalisation de :

A- HGPO75

B- HbA1c

C- Fructosamine

D- Dosage du C peptide

E- Glycémie post repas test

Le diabète gestationnel sera retenu chez cette patiente devant :

A- Glycémie 1 heure après charge orale de glucose à 1,78g/l

B- Glycémie 2 heures après charge orale de glucose à 1,68g/l

C- Glycémie à jeun à 0,93 g/l

D- Hémoglobine glyquée à 6,7% (HPLC)

E- Glycémie 3 heures après charge orale de glucose à 2 g/l

Le diabète gestationnel sera retenu chez cette patiente devant :

A- Glycémie 1 heure après charge orale de glucose à 1,78g/l

B- Glycémie 2 heures après charge orale de glucose à 1,68g/l

C- Glycémie à jeun à 0,93 g/l

D- Hémoglobine glyquée à 6,7% (HPLC)

E- Glycémie 3 heures après charge orale de glucose à 2 g/l

Parmi les complications possibles du diabète gestationnel sur le fœtus :

A- Hydrocéphalie

B- Hydramnios

C- Retard de croissance intra utérin

D- Hyperbilirubinémie

E- Fausses couches

Parmi les complications possibles du diabète gestationnel sur le fœtus :

A- Hydrocéphalie

B- Hydramnios

C- Retard de croissance intra utérin

D- Hyperbilirubinémie

E- Fausses couches

Chez un diabétique connu , une décompensation aigue du diabète doit être recherchée en cas de :

A- Glycémie supérieure à 2,5g/l

B- Douleur abdominale

C- Sueurs nocturnes

D- Vomissements

E- Coma agité

Chez un diabétique connu , une décompensation aigue du diabète doit être recherchée en cas de :

A- Glycémie supérieure à 2,5g/l

B- Douleur abdominale

C- Sueurs nocturnes

D- Vomissements

E- Coma agité

Un patient âgé de 33 ans, sans antécédents familiaux de diabète , une hypothyroïdie chez la mère , diabétique depuis 1 an sous metformine 2g/j et glimépiride 3mg consulte à la salle d'urgence pour un tableau fait de syndrome polyuro-polydipsie , de vomissements , douleurs abdominales avec fièvre à 38,5° C, une TA à 12/5cmHg ,pouls à 90batt/mn ,respiration profonde et ample avec une angine érythémato pultacée

Le bilan biologique : glycémie 2.75 g/l, glycosurie : +++, cétonurie : +++, HCO₃⁻: 13mmol/l , PH :7,23 , kaliémie à 3,35mmol/l, Na : 133mmol/l , CRP :50 créatinine 75 umol/l

Les manifestations cliniques de l'acidocétose chez ce patient sont :

A- Douleurs abdominales

B- Fièvre

C- Dyspnée

D- Syndrome polyuro-polydipsie

E- Troubles de la conscience

Les manifestations cliniques de l'acidocétose chez ce patient sont :

A- Douleurs abdominales

B- Fièvre

C- Dyspnée

D- Syndrome polyuro-polydipsie

E- Troubles de la conscience

Les critères de diagnostic de l' acidocétose diabétique chez ce patient :

A- Déshydratation

B- PH à 7,23

C- Glycémie à 2, 75 g/l

D- Natrémie à 131 mmol/l

E- Bicarbonate à 13mmol/l

Les critères de diagnostic de l' acidocétose diabétique chez ce patient :

A- Déshydratation

B- PH à 7,23

C- Glycémie à 2, 75 g/l

D- Natrémie à 131 mmol/l

E- Bicarbonate à 13mmol/l

L'hypokaliémie chez ce patient est due à :

A- Diurèse osmotique

B- Vomissement

C- Hyperaldostéronisme

D- Polypnée

E- Carence en insuline

L'hypokaliémie chez ce patient est due à :

A- Diurèse osmotique

B- Vomissement

C- Hyperaldostéronisme

D- Polypnée

E- Carence en insuline

Après avoir jugulé l'acidocétose, le patient est insuliné et rapporte que son médecin traitant lui a demandé un bilan comprenant une HbA1C à 10% et des anticorps anti GAD positifs .

vous avez retenu le diabète LADA (Latent Auto-immune Diabète of Adults) chez ce patient devant :

A- Cétose spontanée

B- Positivité des anticorps anti pancréas

C- Initiation de l'insuline 1 an après le diagnostic

D- Diabète mal équilibré

E- Âge au diagnostic supérieure à 30 ans

Après avoir jugulé l'acidocétose, le patient est insuliné et rapporte que son médecin traitant lui a demandé un bilan comprenant une HbA1C à 10% et des anticorps anti GAD positifs .

vous avez retenu le diabète LADA (Latent Auto-immune Diabète of Adults) chez ce patient devant :

A- Cétose spontanée

B- Positivité des anticorps anti pancréas

C- Initiation de l'insuline 1 an après le diagnostic

D- Diabète mal équilibré

E- Âge au diagnostic supérieure à 30 ans

Une patiente âgée de 19 ans, élève au baccalauréat , diabétique depuis 3 ans sous insuline humaine changée depuis 2 mois par analogue de l'insuline selon un schéma basal bolus sans titration, consulte à la salle d'urgence pour un tableau fait d'asthénie ,vomissements , douleurs abdominales dans un contexte de syndrome grippal avec a l'examen une TA à 10/5cmHg ,pouls à 85batt/mn ,respiration profonde et ample
Le bilan biologique : glycémie 2.85 g/l, glycosurie : +++, cétonurie : +++, HCO_3^- : 8 mmol/l , PH :6,95 , kaliémie à 3,8mmol/l, Na : 133mmol/l , CRP : 30 , créatinémie à 138, urée 16 mmol/l , TSH à 1,22UI/l

Une acidocétose est retenue .

La gravité du tableau présenté par cette patiente est attestée par :

A- Un PH à 6,95

B- Une respiration profonde et ample

C- Une natrémie à 133 mmol/l

D- Une cétonurie à +++

E- Insuffisance rénale aigue

La gravité du tableau présenté par cette patiente est attestée par :

A- Un PH à 6,95

B- Une respiration profonde et ample

C- Une natrémie à 133 mmol/l

D- Une cétonurie à +++

E- Insuffisance rénale aigue

Parmi les causes qui peuvent expliquer la décompensation Chez cette patiente on trouve :

A- Syndrome grippal

B- Absence de titration des analogues de l'insuline

C- Stress psychique

D- Hyperthyroïdie

E- Insuffisance rénale aiguë

Parmi les causes qui peuvent expliquer la décompensation Chez cette patiente on trouve :

A- Syndrome grippal

B- Absence de titration des analogues de l'insuline

C- Stress psychique

D- Hyperthyroïdie

E- Insuffisance rénale aiguë

La persistance des douleurs abdominales après la réanimation d'une acidocétose doit faire rechercher :

A- Une hypokaliémie

B- Une Altération de la motilité gastro-intestinale

C- Une pancréatite aigue

D- Une Hyperthyroïdie

E- Une Hypochlorémie

La persistance des douleurs abdominales après la réanimation d'une acidocétose doit faire rechercher :

A- Une hypokaliémie

B- Une Altération de la motilité gastro-intestinale

C- Une pancréatite aigue

D- Une Hyperthyroïdie

E- Une Hypochlorémie

Cette patiente nécessite en urgence les mesures thérapeutiques initiales suivantes :

A- Perfusion de macromolécules

B- De l'insuline rapide par seringue électrique

C- Perfusion de bicarbonates

D- Apport de chlorure de potassium

E- Perfusion de sérum physiologique

Cette patiente nécessite en urgence les mesures thérapeutiques initiales suivantes :

A- Perfusion de macromolécules

B- De l'insuline rapide par seringue électrique

C- Perfusion de bicarbonates

D- Apport de chlorure de potassium

E- Perfusion de sérum physiologique

La réhydratation au cours de l'acidocétose diabétique permet de :

- A- Prévenir les thromboses veineuses
- B- Restaurer la volémie
- C- Améliorer la Perfusion glomérulaire
- D- Réduire l'hyperglycémie
- E- Corriger l'acidose

La réhydratation au cours de l'acidocétose diabétique permet de :

A- Prévenir les thromboses veineuses

B- Restaurer la volémie

C- Améliorer la Perfusion glomérulaire

D- Réduire l'hyperglycémie

E- Corriger l'acidose

Cette patiente nécessite une surveillance horaire de :

A- Glycémie veineuse

B- Ionogramme sanguin

C- Cétonurie

D- Etat respiratoire

E- Diurèse

Cette patiente nécessite une surveillance horaire de :

A- Glycémie veineuse

B- Ionogramme sanguin

C- Cétonurie

D- Etat respiratoire

E- Diurèse

Cette patiente nécessite après cette réanimation :

- A- Dosage de cortisol
- B- Ajustement des doses d'insuline
- C- Activité physique régulière
- D- Deux collations journalières
- E- Régime normo calorique

Cette patiente nécessite après cette réanimation :

A- Dosage de cortisol

B- Ajustement des doses d'insuline

C- Activité physique régulière

D- Deux collations journalières

E- Régime normo calorique

Parmi les mesures préventives de l'acido-cétose chez un diabétique :

- A- Initiation précoce de l'insuline si insulino requérance
- B- Autosurveillance glycémique
- C- Apport hydrique suffisant
- D- Recherche de cétonurie en cas d'hyperglycémie
- E- Régime pauvre en lipide

Parmi les mesures préventives de l'acido-cétose chez un diabétique :

- A- Initiation précoce de l'insuline si insulino requérance
- B- Autosurveillance glycémique
- C- Apport hydrique suffisant
- D- Recherche de cétonurie en cas d'hyperglycémie
- E- Régime pauvre en lipide

Au cours de la décompensation acidocétosique on peut trouver :

A- Une Hyperlipidémie

B- Une élévation modérée des lipases

C- Une Hyperuricémie

D- Une Hypocalcémie

E- Une Elévation des transaminases

Au cours de la décompensation acidocétosique on peut trouver :

A- Une Hyperlipidémie

B- Une élévation modérée des lipases

C- Une Hyperuricémie

D- Une Hypocalcémie

E- Une Elévation des transaminases

Parmi les signes qu' on peut trouver au cours du coma hyperosmolaire il y a :

A- Agitation

B- Asymétrie des réflexes

C- Hypersudation froide

D- Déshydratation globale

E-Signe de babinski

**Parmi les signes qu' on peut trouver au cours du coma
hyperosmolaire il y a :**

A- Agitation

B- Asymétrie des réflexes

C- Hypersudation froide

D-Déshydratation globale

E-Signe de babinski

Mr Salem âgé de 72 ans, tabagique ,aux ATCDS Diabète type 2 depuis 20 ans traité par metformine 850: 3cp /j gliclazide 120mg/j en arrêt de suivi depuis 1 an . HTA sous amlodipine .Il Vit seul depuis le décès de sa femme mais il est autonome . il se présente aux urgences pour vomissements et diarrhées ayant débuté il y a 5 jours . Il dit ne plus s'alimenter et boire très peu a cause des nausées persistantes . Il signale également une exagération de la polyurie polydipsie depuis 15 jours

L'examen trouve : un patient somnolent , obnubilé

T : 38,8 ; TA : 10/6 ; pouls : 96bpm, FR : 18 cycle min ;

pli cutané persistant , langue sèche et cernes oculaires

Lasbtix : Glucose++++ ; Acétone : 0 ;

***Biologie : glycémie: 35 mmol/l Na⁺ : 133 mmol/l, K⁺ : 5,5 mmol/l;**

HCO₃⁻ : 21mmol/l Creat : 150 µmol/l; urée : 14 mmol/l

CRP: 90 culot urinaire : leucocyte 2000 els /mm³ , troponine négative

NFS: L : 15000el/mm³ , HbA1c 8,9%

***A l' ECG : onde Q de nécrose**

Ce patient présente :

- A- Une gastroentérite
- B- Une infection urinaire
- C- Un diabète mal équilibré
- D- Un syndrome coronarien aigu
- E- Un haut risque cardiovasculaire

Ce patient présente :

A- Une gastroentérite

B- Une infection urinaire

C- Un diabète mal équilibré

D- Un syndrome coronarien aigu

E- Un haut risque cardiovasculaire

Une décompensation hyperosmolaire est évoquée devant :

A-Hyperglycémie à 35 mmol/l

B-Troubles de la conscience

C- Glycosurie à ++++

D- Taux de bicarbonates inférieur à 18mmol/l

E- Osmolarité plasmatique élevée

Une décompensation hyperosmolaire est évoquée devant :

A-Hyperglycémie à 35 mmol/l

B-Troubles de la conscience

C- Glycosurie à ++++

D- Taux de bicarbonates inférieur à 18mmol/l

E- Osmolarité plasmatique élevée

Cette décompensation est favorisée chez ce patient par:

A-Age

B- Traitement par amlodipine

C- Diabète de type 2 négligé

D- Insuffisance rénale

E- Diminution des apports hydriques

Cette décompensation est favorisée chez ce patient par:

A-Age

B- Traitement par amlodipine

C- Diabète de type 2 négligé

D- Insuffisance rénale

E- Diminution des apports hydriques

La réanimation initiale de ce patient repose sur :

A- Apport de potassium

B- Perfusion de sérum salé isotonique à 9‰

C- Insulinothérapie par voie sous cutanée

D- Glucagon

E- Anti coagulation préventive

La réanimation initiale de ce patient repose sur :

A- Apport de potassium

B- Perfusion de sérum salé isotonique à 9‰

C- Insulinothérapie par voie sous cutanée

D- Glucagon

E- Anti coagulation préventive

Au cours de la réanimation , ce patient court le risque de :

A- Thrombose veineuse

B- Œdème cérébral

C- Accident vasculaire cérébral

D- Pollakiurie

E- Cytolyse hépatique

Au cours de la réanimation , ce patient court le risque de :

A- Thrombose veineuse

B- Œdème cérébral

C- Accident vasculaire cérébral

D- Pollakiurie

E- Cytolyse hépatique

A propos de la prise en charge de la décompensation hyperosmolaire :

- A- Elle peut se faire en ambulatoire
- B- L'insuline sera donnée par voie S/C si la glycémie atteint 2,5 g/L
- C- Les doses d'insuline utilisées sont importantes
- D- Du soluté glucose à 5% sera donné si la glycémie est $< 2,50$ g/l
- E- La réhydratation précèdera l'insulinothérapie

A propos de la prise en charge de la décompensation hyperosmolaire :

A- Elle peut se faire en ambulatoire

B- L'insuline sera donnée par voie S/C si la glycémie atteint 2,5 g/L

C- Les doses d'insuline utilisées sont importantes

D- Du soluté glucose à 5% sera donné si la glycémie est $< 2,50$ g/l

E- La réhydratation précèdera l'insulinothérapie

Après amélioration de l'état du patient , le médecin traitant décide de modifier le schéma thérapeutique et ce, pour éviter l'apparition des complications chroniques .L'ordonnance de ce patient va comporter :

- A. Inhibiteur de SGLT2
- B. Analogue lent de l'insuline
- C. Inhibiteur de DPP4
- D. Gliclazide
- E. Analogues GLP1

Après amélioration de l'état du patient , le médecin traitant décide de modifier le schéma thérapeutique et ce, pour éviter l'apparition des complications chroniques .L'ordonnance de ce patient va comporter :

A. Inhibiteur de SGLT2

B. Analogue lent de l'insuline

C. Inhibiteur de DPP4

D. Gliclazide

E. Analogues GLP1

L'hypoglycémie chez le diabétique est défini par :

A-Glycémie inférieure à 0,5 g/l

B- Présence de manifestations neuroglucopéniques

C- Amélioration des symptômes par le resucrage

D- Existence de symptômes neurovégétatifs

E- Récidive de symptômes après resucrage oral

L'hypoglycémie chez le diabétique est défini par :

A-Glycémie inférieure à 0,5 g/l

B- Présence de manifestations neuroglucopéniques

C- Amélioration des symptômes par le resucrage

D- Existence de symptômes neurovégétatifs

E- Récidive de symptômes après resucrage oral

Concernant le coma hypoglycémique :

A- Il est d'installation brutale

B- Le patient est agité

C- Il existe des signes de localisation neurologique

D- Il s'y associe des signes d'irritation pyramidale

E- La confirmation nécessite de réaliser une glycémie veineuse

Concernant le coma hypoglycémique :

A- Il est d'installation brutale

B- Le patient est agité

C- Il existe des signes de localisation neurologique

D- Il s'y associe des signes d'irritation pyramidale

E- La confirmation nécessite de réaliser une glycémie veineuse

MA , âgée de 30 ans, présente un diabète de type 1 depuis l'âge de 13 ans sous un schéma insulinique de type basal-bolus, maladie coéliquaue sous régime sans gluten irrégulièrement suivi. Le carnet d'auto surveillance révèle une variabilité des valeurs glycémiques avec des extrêmes entre 0,38 et 3,4g/d au cours des 3 derniers mois.

La patiente signale que certaines valeurs basses sont tout à fait asymptomatiques et découvertes fortuitement par l'autosurveillance glycémique et qu' elle se plaint d'une pesanteur post prandiale

Elle a présenté récemment un coma hypoglycémique nocturne , avec agitation , sueurs profuses et une glycémie à 0,2g/l qui a nécessité le recours a un service médicalisé urgent pour un resucrage intra veineux

L'hypoglycémie est étiquetée sévère chez cette patiente devant :

A-Glycémie inférieure à 0,5 g/l

B-Présence de signes de neuroglucopénies

C-Antécédents d'hypoglycémie non ressenties

D- Recours au resucrage intraveineux

E- Sueurs profuses

L'hypoglycémie est étiquetée sévère chez cette patiente devant :

A-Glycémie inférieure à 0,5 g/l

B-Présence de signes de neurogluopénies

C-Antécédents d'hypoglycémie non ressenties

D-Recours au resucrage intraveineux

E-Sueurs profuses

Les facteurs responsables de la sévérité de l'hypoglycémie chez cette patiente :

- A- Le schéma insulinique basal bolus
- B- Une neuropathie autonome digestive
- C- Une éducation insuffisante
- D- La survenue nocturne
- E- La maladie coéliquue

Les facteurs responsables de la sévérité de l'hypoglycémie chez cette patiente :

A- Le schéma insulinique basal bolus

B- Une neuropathie autonome digestive

C- Une éducation insuffisante

D- La survenue nocturne

E- La maladie cœliaque

Les hypoglycémie non ressenties font exposer cette patiente aux risques de :

A-Coma

B-Accident de la voie publique

C-Prise de poids

D-Insuffisance rénale aiguë

E-Accidents cardiovasculaires

Les hypoglycémie non ressenties font exposer cette patiente aux risques de :

A-Coma

B-Accident de la voie publique

C-Prise de poids

D-Insuffisance rénale aiguë

E-Accidents cardiovasculaires

Monsieur P., 70 ans, diabétique de type 2 depuis 15 ans, est traité par glimipéride 3 mg/j et metformine 1000 mg x 2/j. Il n'a pas d'antécédent cardiovasculaire connu. Il vit seul. Il est retrouvé le matin confus et agité par son fils . À l'arrivée du SAMU, sa glycémie capillaire est à 0,38 g/L . Il reçoit un resucrage avec amélioration rapide de son état.

Cependant, quelques heures plus tard, aux urgences, une nouvelle hypoglycémie est constatée à 0,42 g/L, alors qu'il n'a toujours pas repris d'alimentation solide. Il est à nouveau resucré.

La conduite Immédiate chez ce patient doit être une :

A-Hospitalisation

B- PIV sérum glucosé pendant 24 -48 h

C- Administration de 1 mg de glucagon

D- Resucrage et le réadresser à son domicile

E- Perfusion intraveineuse de 50 cc de sérum glucosé à 30%

La conduite Immédiate chez ce patient doit être une :

A-Hospitalisation

B- PIV sérum glucosé pendant 24 -48 h

C- Administration de 1 mg de glucagon

D- Resucrage et le réadresser à son domicile

E- Perfusion intraveineuse de 50 cc de sérum glucosé à 30%

L'hospitalisation de ce patient est indiquée dès le premier épisode hypoglycémique devant :

A- Age du patient

B- vécu isolé du patient

C-Prise de Glimépiride

D-Traitement par metformine

E-Risque de récurrence

L'hospitalisation de ce patient est indiquée dès le premier épisode hypoglycémique devant :

A- Age du patient

B- vécu isolé du patient

C-Prise de Glimépiride

D-Traitement par metformine

E-Risque de récurrence

Les hypoglycémies liées aux sulfamides justifient une surveillance hospitalière prolongée car :

A-Elles sont plus sévères

B- Les sulfamides ont une durée d'action prolongée

C- Les sulfamides bloquent l'effet du glucagon

D-Les hypoglycémies sont plus prolongées

E-Elles récidivent immédiatement après resucrage oral

Les hypoglycémies liées aux sulfamides justifient une surveillance hospitalière prolongée car :

A-Elles sont plus sévères

B- Les sulfamides ont une durée d'action prolongée

C- Les sulfamides bloquent l'effet du glucagon

D-Les hypoglycémies sont plus prolongées

E-Elles récidivent immédiatement après resucrage oral

Vous allez rechercher pour expliquer ce malaise:

- A- Erreur dans la dose de metformine
- B- Présence de zones de lipodystrophies
- C- Prise de sulfamides anti bactériens
- D- Pratique d'un effort physique imprévu
- E- Dégradation de la fonction rénale

Vous allez rechercher pour expliquer ce malaise:

A- Erreur dans la dose de metformine

B- Présence de zones de lipodystrophies

C- Prise de sulfamides anti bactériens

D- Pratique d'un effort physique imprévu

E- Dégradation de la fonction rénale

Le Traitement du malaise hypoglycémique sévère sous sulfamides hypoglycémiants repose sur :

- A- 50 ml de serum glucose à 30% per os
- B- 40g de pain avec du beurre
- C- Une ampoule de glucagon
- D- Perfusion de sérum glucosé à 10%
- E- 30ml de serum glucose à 30% per voie intra veineuse

Le traitement immédiat du malaise hypoglycémique sévère sous sulfamides hypoglycémiants repose sur :

A- 50 ml de serum glucose à 30% per os

B- 40g de pain avec du beurre

C- Une ampoule de glucagon

D- Perfusion de sérum glucosé à 10%

E- 30ml de serum glucose à 30% per voie intra veineuse

Monsieur B., 54 ans, tabagique , hypertendu est suivi pour un diabète de type 2 depuis 15 ans. Il consulte pour des douleurs des pieds, à type de brûlures et picotements, majorées la nuit et insomniantes . Il se plaint également d'une diminution de la sensibilité au niveau des orteils et d'une impression de "marcher sur du coton".

À l'examen clinique : Taille :155cm , pouls 95batt/mn ,TA125/80cm/Hg , Pieds secs froids , diminution de la pilosité ,réflexes achilléens abolis , pouls pédieux faibles hypoesthésie en chaussettes .

Glycémie à jeun : 1,65 g/L HbA1c : 8,5 %

Le diagnostic d'une neuropathie périphérique diabétique est évoqué chez ce patient devant :

A- Impression de marcher sur du coton

B- Hypoesthésie des orteils

C- Pieds froids

D- Réflexes achilléens abolis

E- Tachycardie

Le diagnostic d'une neuropathie périphérique diabétique est évoqué chez ce patient devant :

A- Impression de marcher sur du coton

B- Hypoesthésie des orteils

C- Pieds froids

D- Réflexes achilléens abolis

E- Tachycardie

Parmi les facteurs de risque de la neuropathie périphérique chez ce patient on trouve :

A- Age

B- Sexe

C- Durée du diabète

D- Hypertension artérielle

E- Tachycardie

Parmi les facteurs de risque de la neuropathie périphérique chez ce patient on trouve :

A- Age

B- Sexe

C- Durée du diabète

D- Hypertension artérielle

E- Tachycardie

la neuropathie périphérique expose le patient aux risques de :

A- Brulures

B- Gangrène

C- Blessures

D-Hypoglycémies non ressenties

E- Mal perforant plantaire

la neuropathie périphérique expose le patient aux risques de :

A- Brulures

B- Gangrène

C- Blessures

D-Hypoglycémies non ressenties

E- Mal perforant plantaire

L' amélioration des symptômes présentés par ce patient passe par :

A- Equilibration du diabète

B- Traitement par antiagrégant

C- Traitement par insuline

D- Equilibration de l'hypertension artérielle

E- Prescription de prégabaline

L' amélioration des symptômes présentés par ce patient passe par :

A- Equilibration du diabète

B- Traitement par antiagrégant

C- Traitement par insuline

D- Equilibration de l'hypertension artérielle

E- Prescription de prégabaline

L'origine artérielle d'une lésion du pied chez un patient diabétique est évoquée devant :

A- Peau fine

B- Déformation en griffe des orteils

C-Absence de douleur

D-Dépilation des jambes

E-Ongles épais

L'origine artérielle d'une lésion du pied chez un patient diabétique est évoquée devant :

A- Peau fine

B- Déformation en griffe des orteils

C-Absence de douleur

D-Dépilation des jambes

E-Ongles épais

**Monsieur A.B., 65 ans, est suivi pour un diabète de type 2 mal équilibré diagnostiqué il y a 8 ans. Il suit un traitement par metformine 1g 2 fois /j et gliclazide 60mg/j amlodipine 5 mg/j, et atorvastatine 20 mg/j
TA : 145/85 mmHg IMC : 31 kg/m² Pas d'œdèmes**

Bilan:

Glycémie à jeun :1,95 g/L HbA1c 8,9 %

DFG 40 mL/min/1.73m² (depuis 2 ans) ECBU négatif

BU Protéinurie +++

Albuminurie 380 mg/g Kaliémie 4,2 mmol/L

Cholesterol LDL : 0,78g/l

Echo rénale 2 reins de taille normale

Fond d'œil : micro-anévrismes,

Le stade de l'atteinte rénale de ce patient est une :

- A- Hyperfiltration glomérulaire
- B- Néphropathie avérée
- C- Néphropathie silencieuse
- D- Néphropathie débutante
- E- Insuffisance rénale terminale

Le stade de l'atteinte rénale de ce patient est une :

A- Hyperfiltration glomérulaire

B- Néphropathie avérée

C- Néphropathie silencieuse

D- Néphropathie débutante

E- Insuffisance rénale terminale

L'origine diabétique de cette néphropathie est évoquée devant:

- A. Albuminurie persistante
- B. Absence d'hématurie
- C. Présence d'une rétinopathie diabétique
- D. Début brutal de l'insuffisance rénale
- E. Déséquilibre chronique du diabète

L'origine diabétique de cette néphropathie est évoquée devant:

- A. Albuminurie persistante
- B. Absence d'hématurie
- C. Présence d'une rétinopathie diabétique
- D. Début brutal de l'insuffisance rénale
- E. Déséquilibre chronique du diabète

Pour prévenir l'aggravation de l'atteinte rénale chez ce patient , on doit :

- A. Conseiller une activité physique régulière
- B. Régime riche en protéines pour compenser les pertes urinaires
- C. Corriger l'hyperkaliémie
- D. Mettre un inhibiteur sglt2
- E. Équilibrer son diabète

Pour prévenir l'aggravation de l'atteinte rénale chez ce patient , on doit :

- A. Conseiller une activité physique régulière**
- B. Régime riche en protéines pour compenser les pertes urinaires
- C. Corriger l'hyperkaliémie
- D. Mettre un inhibiteur sglt2**
- E. Équilibrer son diabète**

La prise en charge de ce patient nécessite de :

A- Augmenter le gliclazide

B- Initier une insuline basale

C- Augmenter l'atorvastatine

D- Ajouter un vasodilatateur

E- Réduire la metformine à 1g/j

La prise en charge de ce patient nécessite de :

A- Augmenter le gliclazide

B- Initier une insuline basale

C- Augmenter l'atorvastatine

D- Ajouter un vasodilatateur

E- Réduire la metformine à 1g/j

L'ischémie myocardique chez le diabétique :

A- Peut déséquilibrer un diabète

B- Peut se manifester par des douleurs épigastriques

C- Elle peut être asymptomatique

D- Un ECG normal suffit pour éliminer le diagnostic

E- Impose une prise en charge globale des facteurs de risque

L'ischémie myocardique chez le diabétique :

A- Peut déséquilibrer un diabète

B- Peut se manifester par des douleurs épigastriques

C- Elle peut être asymptomatique

D- Un ECG normal suffit pour éliminer le diagnostic

E- Impose une prise en charge globale des facteurs de risque

Monsieur R., 75 ans, est diabétique de type 2 depuis 22 ans, avec une HbA1c à 8,1 % sous traitement par metformine et insuline basale.

Il est hypertendu, dyslipidémique, ancien fumeur (60 PA) arrêté depuis 6 ans. Il prend également un antagoniste récepteur angiotensine , une statine et Anti agrégant plaquettaire.

Il se plaint d'une douleur thoracique à l'effort depuis 2 mois, avec dyspnée d'effort , des douleurs au mollets bilatérales avec un périmètre de marche à 200 m

Il rapporte un épisode récent de trouble du langage transitoire résolu en moins d'une heure, sans séquelle

TA : 138/86 mmHg FC : 76 bpm IMC : 25 kg/m²

Pouls périphériques pédieux diminués

ECG Bloc de branche gauche

FO microanévrismes

Vous relever comme facteurs de risque chez ce patient :

A- HTA

B- Tabac

C- Accident vasculaire cérébral

D- Diabète type2

E- Dyslipidémie

Vous relever comme facteurs de risque chez ce patient :

A- HTA

B- Tabac

C- Accident vasculaire cérébral

D- Diabète type2

E- Dyslipidémie

Ce patient présente comme comorbidités :

A- Risque cardiovasculaire très élevé

B- Accident vasculaire cérébral transitoire

C- Rétinopathie proliférante

D- Syndrome coronarien aigu

E- Artérite des membres inférieurs

Ce patient présente comme comorbidités :

A- Risque cardiovasculaire très élevé

B- Accident vasculaire cérébral transitoire

C- Rétinopathie proliférante

D- Syndrome coronarien aigu

E- Artérite des membres inférieurs

Chez ce patient ,les explorations doivent êtres complétées par :

A- Scintigraphie myocardique

B- Artériographie des membres inférieures

C- Échographie-doppler des membres inférieures

D- Echodoppler des troncs supra aortiques

E- Polygraphie ventilatoire

Chez ce patient ,les explorations doivent êtres complétées par :

A- Scintigraphie myocardique

B- Artériographie des membres inférieures

C- Échographie-doppler des membres inférieures

D- Echodoppler des troncs supra aortiques

E- Polygraphie ventilatoire

**Les médicaments qui réduisent le risque cardiovasculaire
chez ce patient incluent :**

A- Metformine

B- Statines

C- Antagoniste récepteur angiotensine

D- Insuline

E- Anti agrégant plaquettaire

**Les médicaments qui réduisent le risque cardiovasculaire
chez ce patient incluent :**

A- Metformine

B- Statines

C- Antagoniste récepteur angiotensine

D- Insuline

E- Anti agrégant plaquettaire

Les adaptations du traitement antidiabétique pour réduire le risque cardiovasculaire chez ce patient incluent :

A- Arrêt metformine

B- Introduction de la dapagliflozine

C- Changement par les analogues de l'insuline

D- Prescription de la liraglutide

E- Prescription de la sitagliptine

Les adaptations du traitement antidiabétique pour réduire le risque cardiovasculaire chez ce patient incluent :

A- Arrêt metformine

B- Introduction de la dapagliflozine

C- Changement par les analogues de l'insuline

D- Prescription de la liraglutide

E- Prescription de la sitagliptine

Les objectifs thérapeutiques chez ce patient :

A- HbA1C entre 7- 7,5%

B- LDL cholestérol inférieur à 0,55g/l

C- Reduction du poids

D- Glycémie à jeun entre 0,7 et 1,2 g/l

E- Microalbuminurie inférieure à 30mg/g

Les objectifs thérapeutiques chez ce patient :

A- HbA1C entre 7- 7,5%

B- LDL cholestérol inférieur à 0,55g/l

C- Reduction du poids

D- Glycémie à jeun entre 0,7 et 1,2 g/l

E- Microalbuminurie inférieure à 30mg/g

Les objectifs thérapeutiques chez ce patient :

A- HbA1C entre 7- 7,5%

B- LDL cholestérol inférieur à 0,55g/l

C- Reduction du poids

D- Glycémie à jeun entre 0,7 et 1,2 g/l

E- Microalbuminurie inférieure à 30mg/g

Madame K., 59 ans, est suivie pour un diabète de type 2 diagnostiqué il y a 3 ans.

Elle est traitée par metformine 1000 mg x 2/j.

Elle présente une HTA bien contrôlée, un IMC à 32 kg/m², une dyslipidémie traitée par statine, et n'a pas d'antécédent cardiovasculaire connu.

Son dernier bilan biologique montre :HbA1c : 8,2 %

Créatininémie : normale GFR estimée : 78 mL/min/1,73 m²

LDL-c : 0,92 g/L

Elle est asymptomatique et son poids est stable

Le traitement par metformine chez cette patiente peut donner :

A-Flatulence digestive

B-Constipation

C- Vomissement

D-Insuffisance rénale

E-Douleur de l'hypochondre droit

Le traitement par metformine chez cette patiente peut donner :

A-Flatulence digestive

B-Constipation

C- Vomissement

D-Insuffisance rénale

E-Douleur de l'hypochondre droit

Pour éviter ces effets il faut :

A-Prendre le traitement à la fin du repas

B-Faire une échographie abdominale annuelle

C-Augmenter progressivement la dose

D-Associer un laxatif

E- Suivre un régime pauvre en fibre

Pour éviter ces effets il faut :

A-Prendre le traitement à la fin du repas

B-Faire une échographie abdominale annuelle

C-Augmenter progressivement la dose

D-Associer un laxatif

E- Suivre un régime pauvre en fibre

Pour améliorer l'équilibre glycémique vous allez :

A-Augmenter la dose de metformine à 3g/j

B- Initier une insuline NPH 2 fois par jour

C-Ajouter la vildagliptine

D-Intensifier les mesures hygiéno diététiques

E- Ajouter un sulfamide hypoglycémiant

Pour améliorer l'équilibre glycémique vous allez :

A-Augmenter la dose de metformine à 3g/j

B- Initier une insuline NPH 2 fois par jour

C-Ajouter la vildagliptine

D-Intensifier les mesures hygiéno diététiques

E- Ajouter un sulfamide hypoglycémiant

Patient âgée de 51 ans diabétique type1 depuis 30 ans qui consulte pour le contrôle de son diabète . Il est sous 2 insulines NPH 18 U matin et 16 U le soir .Il consulte pour une sensation de pesanteur post-prandiale associée parfois à des vomissements . Il rapporte également des épisodes de diarrhées nocturnes et des troubles de l'érection sans baisse de libido. Il a déjà une rétinopathie diabétique minime et des paresthésies des extrémités .

Examen :TA en position couchée : 155/90 mmHg TA en position debout : 145/85 mmHgFC : 58 bpm,

Le bilan révèle : Glycémie : 1,9g/l mmol/l HbA1c : 9%

Parmi les manifestations de la neuropathie végétative autonome chez ce patient :

A-Bradycardie

B- Dysfonction érectile

C-Pesanteur post prandiale

D-Hypotension orthostatique

E- Diarrhée nocturne

Parmi les manifestations de la neuropathie végétative autonome chez ce patient :

A-Bradycardie

B- Dysfonction érectile

C-Pesanteur post prandiale

D-Hypotension orthostatique

E- Diarrhée nocturne

La prise en charge adaptée à ce patient :

A-Intensification par un schéma basal bolus

B-Traitement par gabapentine

C-Fractionnement des repas

D-Régime sans gluten

E- Traitement par tadalafil

La prise en charge adaptée à ce patient :

A-Intensification par un schéma basal bolus

B-Traitement par gabapentine

C-Fractionnement des repas

D-Régime sans gluten

E- Traitement par tadalafil

Pour éviter l'aggravation de la rétinopathie diabétique chez ce patient on doit :

A-Equilibrer le diabète

B- Faire une photo-coagulation au laser

C- Prescrire des injections intra oculaires des anti-VEGF

D-Equilibrer l' hypertension *artérielle*

E- Arrêter l'alcool

Pour éviter l'aggravation de la rétinopathie diabétique chez ce patient on doit :

A-Equilibrer le diabète

B- Faire une photo-coagulation au laser

C- Prescrire des injections intra oculaires des anti-VEGF

D-Equilibrer l' hypertension *artérielle*

E- Arrêter l'alcool

Un homme de 62 ans avec obésité , sédentaire ,consulte pour diabète de primo découverte découvert lors d'un bilan systématique en milieu de travail . In ne rapporte pas de signes cardinaux et le poids est stable .

Il a bénéficié il y a 2 mois d'une écho cœur pour une dyspnée d'effort : la Fe VG était à 60 %

G: 1,9 g/l HbA1C à 8, 9% créatinine 75umol/l

Vous prescrivez en première intention en plus de règles hygiéno-diététiques chez ce patient :

A-Inhibiteurs SGLT2 et metformine

B-Metformine seule

C-Sulfamides hypoglycémiants

D- Analogues des GLP1

E- Sulfamides et IDPP4

Un homme de 60 ans avec obésité , consulte pour diabète de primo découverte découvert lors d'un bilan systématique en milieu de travail . Il ne rapporte pas de signes cardinaux et le poids est stable .

Il a bénéficié il y a 2 mois d'une écho cœur pour une dyspnée d'effort : la Fe VG était à 60 %

G: 1,9 g/l HbA1C à 8, 7% créatinine 75umol/l

Vous prescrivez en première intention en plus de règles hygiéno-diététiques chez ce patient :

A-Inhibiteurs SGLT2 et metformine

B-Metformine seule

C-Sulfamides hypoglycémiants

D- Analogues des GLP1

E- Sulfamides et IDPP4

La prescription diététique chez ce patient comprend :

A- Apport de 30 g de fibres alimentaires

B- Apport hypocalorique

C- 10% d'acide gras trans

D-Régime hypoglucidique

E- 15% acides gras monoinsaturés

La prescription diététique chez ce patient comprend :

A- Apport de 30 g de fibres alimentaires

B- Apport hypocalorique

C- 10% d'acide gras trans

D-Régime hypoglucidique

E- 15% acides gras monoinsaturés

**Mme S.A âgée de 64 ans diabétique type2 depuis 3ans ,
adressé pour suivi de son diabète . Son traitement comprend
une insuline basale 20 U le soir , metformine 2g/j ,
acarbose 300mg/j , sitagliptine 100mg/j .**

**Elle est asymptomatique et pas d'hypoglycémie . Le bilan trouve une
créatinémie à 140 avec DFG à 42ml/mn . L'atteinte rénale chez cette
patiente nécessite de :**

- A- Mettre la metformine à 1g/j**
- B- Diminuer la dose de l'insuline basale**
- C- Arrêter l'acarbose**
- D- Introduire un ISGLT2**
- E- réduire la sitagliptine à 50mg/j**

**Mme S.A âgée de 64 ans diabétique type2 depuis 3ans ,
adressé pour suivi de son diabète . Son traitement comprend
une insuline basale 20 U le soir , metformine 2g/j ,
acarbose 300mg/j , sitagliptine 100mg/j .**

**Elle est asymptomatique et pas d'hypoglycémie . Le bilan trouve une
créatinémie à 140 avec DFG à 42ml/mn .**

L'atteinte rénale chez cette patiente nécessite de :

A- Mettre la metformine à 1g/j

B- Diminuer la dose de l'insuline basale

C- Arrêter l'acarbose

D- Introduire un ISGLT2

E- Réduire la sitagliptine à 50mg/j

Samir âgé de 44 ans diabétique type2 depuis 18ans , aux ATCD de polyarthrite rhumatoïdes , devant une poussée de sa maladie , la prednisone à 30mg par à été introduite et il vous l'adresse pour équilibration du diabète . Son traitement comprend une insuline basale NPH 20 U le matin et 14 u le soir soir , metformine 1500g/j , Vildagliptine 50 mg 2 fois /j . Il vous ramène un cycle glycémique :

G0: 1,3 g/l , G10h : 2,4g/l , G 16h : 1,8 g/l ,

G20h : 1,4g/l G22h : 1,85g/l

Vous allez chez ce patient :

A-Mettre à 2 insulines premixées

B- Maintenir la metformine

C- Ajouter une glimépiride

D-Ajouter une insuline rapide le matin

E-Ajouter un analogue GLP1

Vous allez chez ce patient :

A-Mettre à 2 insulines premixées

B- Maintenir la metformine

C- Ajouter une glimépiride

D-Ajouter une insuline rapide le matin

E-Ajouter un analogue GLP1

Madame A., 52 ans, diabétique de type 2 depuis 12 ans, est suivie par son médecin traitant. Son traitement comprend la metformine 1000 mg × 2/j et une gliclazide 120mg/j. Malgré une bonne observance du traitement et des mesures hygiéno-diététiques, elle présente une HbA1c à 9,2% au dernier bilan. Elle est obèse (IMC 33), hypertendue, et présente une microalbuminurie persistante.

Un diabète insulino nécessitant est évoqué devant :

- A- HbA1c non à l'objectif
- B- Présence de microalbuminurie
- C- Traitement par gliclazide à 120mg
- D- Bonne observance thérapeutique
- E- Durée du diabète

Madame A., 52 ans, diabétique de type 2 depuis 12 ans, est suivie par son médecin traitant. Son traitement comprend la metformine 1000 mg × 2/j et une gliclazide 120mg/j. Malgré une bonne observance du traitement, elle présente une HbA1c à 9,2% au dernier bilan. Elle est obèse (IMC 33), hypertendue, et présente une microalbuminurie persistante.

Un diabète insulino nécessitant est évoqué devant :

- A- HbA1c non à l'objectif**
- B- Présence de microalbuminurie
- C- Traitement par gliclazide à 120mg**
- D- Bonne observance thérapeutique**
- E- Durée du diabète

Vous allez opter chez ce patient pour :

A- Insister sur les mesures diététiques

B-Mettre sous 2 NPH

C-Maintenir le glimépiride

D-Mettre sous analogue lent plus une rapide

E- Réduire la dose de metformine

Vous allez opter chez ce patient pour :

A- Insister sur les mesures diététiques

B-Mettre sous 2 NPH

C-Maintenir le glimépiride

D-Mettre sous analogue lent plus une rapide

E- Réduire la dose de metformine

Pour éviter la prise de poids chez un diabétique , on doit privilégier :

A- Gliptines

B-Analogues GLP1

C-Analogues de l'insuline

D-Sulfamides

E- Glitazones

Pour éviter la prise de poids chez un diabétique , on doit privilégier :

A- Gliptines

B-Analogues GLP1

C-Analogues de l'insuline

D-Sulfamides

E- Glitazones

Une patiente diabétique type 2 , traitée par metformine 2 g/j. Sa glycémie à jeun est entre 0,9 et 1,1 g/l ,sa glycémie post prandiale est entre 1,8 et 2,2 g/l et l'HbA1c :7,5%

Pour équilibrer le diabète de ce patient vous aller ajouter :

A-Acarbose

B-Novonorm

C-Insuline rapide

D-Sitagliptine

E- Glimépiride

Une patiente diabétique type 2 , traitée par metformine 2 g/j et. Sa glycémie à jeun est entre 0,95 et 1,25 g/l ,sa glycémie post prandiale est entre 1,8 et 2,2 g/l et l'HbA1c :7,6%

Pour équilibrer le diabète de cette patiente vous allez ajouter :

A-Acarbose

B-Novonorm

C-Insuline rapide

D-Sitagliptine

E- Glimépiride

Les conseils que vous allez donner à une femme diabétique type 1 par rapport à la grossesse :

- A-Programmation de la grossesse 1 mois avant la conception
- B- Arrêt de la contraception si objectifs glycémiques atteints
- C-Instauration d'une insulinothérapie optimisée
- D-Faire un bilan de retentissement
- E- Avoir des glycémies entre 1 et 1,60 g/l avant les repas

Les conseils que vous allez donner à une femme diabétique type 1 par rapport à la grossesse :

- A-Programmation de la grossesse 1 mois avant la conception
- B- Arrêt de la contraception si objectifs glycémiques atteints
- C-Instauration d'une insulinothérapie optimisée
- D-Faire un bilan de retentissement
- E- Avoir des glycémies entre 1 et 1,60 g/l avant les repas

Une femme enceinte diabétique ,trouve à l'autosurveillance glycémique des glycémies préprandiales entre 1,3 et 1,5 g/l et une glycémie à 1,9 g/l à 10 h du matin

Vous allez :

- A- Initier une insuline glargine
- B- Lui conseiller un régime hypocalorique
- C- Mettre un analogue rapide le matin
- D- Cibler une glycémie post prandiale à 1,2g/l
- E- Cibler une glycémie préprandiale $< 0,99\text{g/l}$

Une femme enceinte diabétique ,trouve à l'autosurveillance glycémique une glycémie préprandiales entre 1,3 et 1,5 g/l et une glycémie à 1,9 g/l à 10 h du matin .

Vous allez :

A- Initier une insuline glargine

B- Lui conseiller un régime hypocalorique

C- Mettre un analogue rapide le matin

D- Cibler une glycémie post prandiale à 1,2g/l

E- Cibler une glycémie préprandiale < 0,99g/l

Quelles sont les propositions vraies concernant la prise en charge des femmes diabétiques enceintes :

- A- Les analogues de l'insuline sont contre-indiqués
- B- Les consultations sont trimestrielles
- C- L' HbA1c doit être inférieure à 6,5%
- D- Le régime est normo calorique
- E- La metformine peut être poursuivie au cours de la grossesse

Quelles sont les propositions vraies concernant la prise en charge des femmes diabétiques enceintes :

A- Les analogues de l'insuline sont contre-indiqués

B- Les consultations sont trimestrielles

C- L' HbA1c doit être inférieure à 6,5%

D-Le régime est normo calorique

E- La metformine peut être poursuivie au cours de la grossesse

Un homme de 46 ans , chauffeur de taxi , se présente à la consultation se plaignant de fatigue, de vertiges, de polyurie (4 à 5 fois par nuit), d'une perte de poids de 10 kg au cours des 4 derniers mois

Le père est décédé d'une crise cardiaque à 52 ans et était diabétique , La mère est en bonne santé, un frère a un diabète type 2

Glycémie : 23,9 mmol/L , urée : 4 mmol/l , HbA1c : 14%

G /A : +++ /0 ,

IMC 36,2 kg/m² , PA 143/92 mm/Hg , Pouls 87 /minutes

Quel devrait être votre conduite ?

A- Insulinothérapie en bed time

B- Metformine et sulfamides

C-Hospitalisation

D- Insulinothérapie basale et Metformine

E- Metformine et Sulfamides et inhibiteurs de la DPP4

Un homme de 46 ans , chauffeur de taxi , se présente à la consultation se plaignant de fatigue, de vertiges, de polyurie d'une perte de poids de 6 kg au cours des 4 derniers mois
La mère est en bonne santé, un frère a un Diabète type 2
Glycémie : 25 mmol/L , urée : 4 mmol/l , HbA1c : 9%
G /A : +++ /0 ,
IMC 36,2 kg/m² , PA 143/92 mm/Hg , Pouls 87 /minutes

La conduite chez ce patient est:

A- Insulinothérapie en bed time

B- Metformine et sulfamides

C-Hospitalisation

D- Insulinothérapie basale et Metformine

E- Metformine et Sulfamides et inhibiteurs de la DPP4

Parmi les activités sportives possibles chez le patient diabétique on trouve :

A- Rugby

B- Cyclisme

C- Boxe

D- Tapis de salle

E- Natation

Parmi les activités sportives possibles chez le patient diabétique on trouve :

A- Rugby

B- Cyclisme

C- Boxe

D- Tapis de salle

E- Natation

Parmi les effets secondaires des incretinomimétiques :

A-Hépatites

B-Hypoglycémie

C- Infections des voies respiratoires supérieures

D- Dyspepsie

E- Abondance de gaz intestinaux

Parmi les effets secondaires des incretinomimétiques :

A-Hépatites

B-Hypoglycémie

C- Infections des voies respiratoires supérieures

D- Dyspepsie

E- Abondance de gaz intestinaux

Les antidiabétiques qui doivent être arrêtés avant une chirurgie mineure :

A-Metformine

B-Glimipéride

C- Inhibiteurs des SGLT2

D- Inhibiteurs de la DPP-4

E- Insuline lente

Les antidiabétiques qui doivent être arrêtés avant une chirurgie mineure :

A-Metformine

B-Glimipéride

C- Inhibiteurs des SGLT2

D- Inhibiteurs de la DPP-4

E- Insuline lente

Une insulinothérapie transitoire dans le diabète de type 2 peut être indiquée en cas :

A- Pneumopathie sévère

B-Neuropathie hyper algique

C-Infarctus de myocarde

D-Rétinopathie diabétique

E- Neuropathie gastrique autonome

Une insulinothérapie transitoire dans le diabète de type 2 peut être indiquée en cas :

A- Pneumopathie sévère

B-Neuropathie hyper algique

C-Infarctus de myocarde

D-Rétinopathie diabétique

E- Neuropathie gastrique autonome